Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Arrêt cardio-respiratoire

Personne qui ne répond pas et ne respire pas normalement : alerter, masser, défibriller sans attendre. Adulte et enfant (IME).

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas + ne respire pas ou respire anormalement (gasps lents, bruyants) = arrêt cardiaque : 15, massage et DSA tout de suite.

1 · Je sécurise

- Je crie à l'aide : un collègue **appelle le 15** et **apporte le DSA**.
- Seul : j'appelle le 15 en **haut-parleur** et je masse en même temps.
- Sur le dos, sur un plan dur ; au lit sans plan dur : je masse plus fort plutôt que de perdre du temps.
- Le DSA peut être utilisé par **tout témoin** ; un collègue cherche la LAT au dossier.

2 · Je reconnais l'arrêt (10 s au plus)

- Ne répond pas à la voix ni quand je secoue doucement ses épaules.
- Tête basculée, menton relevé : je regarde, j'écoute, je sens **10 s au plus**.
- Pas de respiration ou respiration **anormale** (gasps) = **arrêt cardiaque**.
- Brèves secousses au début : possibles ; je revérifie dès qu'elles cessent.
- Respire normalement : **PLS** (« Perte de connaissance / Malaise »).

3 · Je masse et je défibrille

- Mains au **centre de la poitrine**, bras tendus : enfoncer de **5 à 6 cm**, **100 à 120 fois/min**.
- **30 compressions / 2 insufflations** si je suis formé ; sinon compressions seules, sans arrêt.
- **DSA** dès son arrivée : l'allumer, suivre la voix, reprendre le massage dès qu'il le dit.
- Changer de masseur à chaque analyse (≈ 2 min) ; continuer jusqu'au relais des secours.
- Enfant (IME) : **5 insufflations** puis **15/2** ; enfoncer d'**un tiers** du thorax ; électrodes enfant si dispo.

Je ne fais pas

- Chercher le pouls, prendre la TA ou la glycémie avant de commencer.
- Arrêter le massage, sauf quand le DSA le demande ou pour le relais.
- Toucher la personne pendant l'analyse et le choc.
- Donner à boire ou un médicament ; déplacer la personne sauf danger.

J'alerte

Tout arrêt suspecté :

- **15 (ou 112) immédiatement**, par le premier témoin.
- Le régulateur guide le massage : haut-parleur, je suis ses consignes.

Ensuite, sans arrêter le massage :

- L'IDE (ou d'astreinte) et le cadre d'astreinte.
- Le médecin (coordonnateur, traitant, DOTR) et la famille selon la procédure.

Je surveille et je trace

- Tracer : heure de découverte, début du massage, pose du DSA, chocs, arrivée des secours.
- DLU, traitements et LAT prêts (« Appeler le 15 : le bon message (SAED) »).
- Respiration normale qui revient : PLS, surveillance continue jusqu'aux secours.
- Après : temps d'échange en équipe ; soutien des témoins et des résidents.

Mention de sécurité

Ne répond pas + ne respire pas normalement = 15, massage, DSA. Seule une décision médicale écrite de non-réanimation, connue et retrouvée, permet de ne pas commencer : la dire au 15. Dans le doute, je masse.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ERC Guidelines 2025 : Adult Basic Life Support, Paediatric Life Support, Ethics in Resuscitation (Resuscitation 2025;215) ; DGSCGC, recommandations PSC1 (12/2023) ; CSP art. R.6311-15 (DSA par toute personne), L.1111-11 et R.4127-37-2 ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP).

Réf. DOTR-AS-ACR | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature